

04-03 Estudo: Medicina Intensiva - Casos Clínicos

Com certeza! Preparar-se para a prova de título de Medicina Intensiva exige um estudo aprofundado, focado em diretrizes e na aplicação prática do conhecimento. A seguir, apresento uma sebenta estruturada com base nas discussões de casos clínicos que você forneceu, transformando a passagem de plantão em um material de estudo robusto.

Sebenta de Estudo para Título de Especialista em Medicina Intensiva: Discussão de Casos Clínicos

Este material foi desenvolvido a partir de casos clínicos reais de uma unidade de terapia intensiva, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos em temas prevalentes e de alta complexidade. A abordagem segue as melhores práticas e diretrizes atuais, visando a preparação para a prova de título.

Tópico 1: Manejo do Paciente Coronariopata Agudo Complexo

1.1 Apresentação do Caso Clínico: Sr. Ronaldo, 66 anos

- **Histórico:** Paciente de 66 anos, admitido com quadro de angina, diagnosticado com Doença Arterial Coronariana (DAC) multiarterial em cateterismo (CATE) cardíaco realizado em 30 de março.
- **Achados do CATE:**
 - Artéria Coronária Direita (CD): Ocluída no terço proximal.
 - Artéria Circunflexa (CX) e Ramo Marginal (Mg): Já ocluídas.
 - Artéria Descendente Anterior (DA): Lesão crítica de 90% em terço médio.
 - Tronco de Coronária Esquerda (TCE): Longo, sem lesões.

- **Comorbidade Relevante:** Oclusão de artérias carótidas, elevando o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) perioperatório.
- **Decisão Terapêutica:** Devido ao alto risco cirúrgico (risco de AVC), optou-se por intervenção coronariana percutânea (ICP) em vez de revascularização do miocárdio (RM). Foi realizada angioplastia com implante de *stent* farmacológico em DA com sucesso (**fluxo TIMI 3**), no dia 02 de abril.
- **Evolução Pós-ICP:**
 - Prescrito Dupla Antiagregação Plaquetária (**DAPT**).
 - Episódios de **hipertensão arterial sistêmica**, necessitando de nitroprussiato de sódio (Nipride®) endovenoso.
 - Bradicardia persistente (FC entre **44-57 bpm**), mesmo após suspensão de betabloqueador. Levantada a hipótese de necessidade de Holter para investigação.

1.2 Aprofundamento e Insights Clínicos

1.2.1 Decisão Terapêutica: ICP vs. RM em Doença Multiarterial

A escolha entre ICP e RM em pacientes com DAC multiarterial é um dos pilares da cardiologia moderna e um tema frequente em provas. A decisão é multifatorial e deve ser individualizada, idealmente por um **Heart Team** (time do coração), composto por cardiologista clínico, hemodinamicista e cirurgião cardíaco.

- **Diretrizes Atuais (ESC/EACTS 2018 & AHA/ACC/SCAI 2021):**
 - Para pacientes com doença multiarterial complexa (ex: escore SYNTAX alto), especialmente com diabetes ou disfunção ventricular esquerda, a **RM continua sendo a estratégia de eleição (Classe de Recomendação I)**, por apresentar menores taxas de revascularização do vaso-alvo e eventos cardíacos maiores em longo prazo.
 - No entanto, em pacientes com **alto risco cirúrgico**, como o Sr. Ronaldo devido à doença carotídea oclusiva, a ICP torna-se uma alternativa razoável e, por vezes, preferível (**Classe de Recomendação IIa/IIb**), ponderando o risco-benefício. O risco de AVC peri-RM em pacientes com doença carotídea significativa é um fator decisivo.

Ponto de Atenção: A avaliação do **escore SYNTAX** é fundamental para estratificar a complexidade anatômica da DAC e guiar a decisão. No caso do Sr. Ronaldo, a oclusão crônica de dois dos três principais territórios (CD e CX) e a lesão crítica em DA configuram uma anatomia de alta complexidade. A escolha pela ICP foi uma decisão de exceção baseada no risco proibitivo de outra intervenção.

1.2.2 Bradicardia Pós-Procedimento Coronariano

A bradicardia no pós-ICP pode ter múltiplas etiologias que devem ser investigadas.

1. **Efeito de Fármacos:** A causa mais comum. Mesmo após a suspensão do betabloqueador, seu efeito pode perdurar por 24-48 horas.
2. **Isquemia/Infarto de Parede Inferior:** O nó atrioventricular (AV) é frequentemente irrigado por ramos da artéria coronária direita (em 85-90% dos casos) ou da circunflexa. Uma oclusão ou embolização distal durante o procedimento, mesmo que bem-sucedido na DA, poderia teoricamente comprometer a irrigação do sistema de condução.
3. **Reflexo Bezold-Jarisch:** Estimulação de mecanorreceptores vagais no ventrículo esquerdo (especialmente na parede inferoposterior) pode levar a uma tríade de **hipotensão, bradicardia e vasodilatação periférica**.
4. **Doença do Sistema de Condução Primária:** A bradicardia pode ser uma condição preexistente, apenas exacerbada pelo estresse do procedimento ou pelos fármacos utilizados.

Questão para Prova: Qual a conduta inicial frente a um paciente com bradicardia sintomática no pós-ICP imediato?

Resposta: A primeira etapa é **avaliar a estabilidade hemodinâmica**. Se instável, seguir o algoritmo do ACLS (atropina, marcapasso transcutâneo, etc.). Se estável, como no caso do Sr. Ronaldo, a conduta é **revisar e otimizar a prescrição** (suspender drogas bradicardizantes), monitorar continuamente e investigar a causa. A solicitação de um **Holter de 24 horas** é apropriada para documentar a frequência e a gravidade da bradicardia, correlacionar com sintomas e identificar pausas ou bloqueios avançados que possam indicar a necessidade de um marcapasso definitivo.

Tópico 2: Manejo da Paciente Idosa com Choque Séptico e Cuidados de Fim de Vida

2.1 Apresentação do Caso Clínico: Sra. Maria de Lourdes, 94 anos

- **Diagnósticos:** Choque séptico de foco pulmonar, Doença Renal Crônica (DRC) agudizada, Endocardite Infecciosa (EI) provável, Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER, FEVE 24%), valvopatia aórtica e mitral complexa.
- **Contexto Clínico:** Paciente muito idosa, com funcionalidade prévia já comprometida. Hemoculturas persistindo positivas para *Staphylococcus aureus*

Oxacilino-sensível (OXA-S), mesmo após início de antibioticoterapia. Possui marcapasso cardíaco prévio.

- **Decisão Terapêutica e Limitação de Suporte:**

- Em discussão com a família, foram definidas **Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV)**.
- **Limitações:** Não intubar (Não-IOT), não reanimar (Não-RCP), não iniciar diálise.
- Permitido uso de droga vasoativa (DVA) com **teto de 0.5 mcg/kg/min de noradrenalina**.

- **Evolução:** Evoluiu com desconforto respiratório e dor. Iniciada bomba de infusão contínua (BIC) de **morfina** para controle de sintomas (paliativo), com boa resposta. A equipe de infectologia, frente à não-proposta de intervenção cirúrgica no marcapasso ou válvulas, questiona a manutenção do antibiótico em longo prazo.

2.2 Aprofundamento e Insights Clínicos

2.2.1 Endocardite em Paciente com Dispositivo Cardíaco e Limitação Terapêutica

A endocardite associada a dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) é uma condição grave com alta mortalidade.

- **Diretrizes Atuais (ESC 2023 Guideline for the Management of Endocarditis):**
 - A **extração completa e precoce do sistema (cabos e gerador)** é a pedra angular do tratamento, sendo uma **Recomendação Classe I** para pacientes com bacteremia persistente, vegetações >10 mm ou complicações.
 - A antibioticoterapia isolada, sem a remoção do dispositivo infectado, está associada a taxas de falha e recidiva extremamente elevadas. O biofilme que se forma nos cabos e no gerador é impermeável à maioria dos antibióticos.

Ponto-Chave: No caso da Sra. Maria de Lourdes, a decisão familiar de não proceder com intervenções invasivas (como a extração do marcapasso) muda fundamentalmente o objetivo do tratamento. O foco deixa de ser a **cura** da endocardite e passa a ser o **conforto** e o controle de sintomas. Portanto, a discussão da infectologia sobre a futilidade da manutenção do antibiótico em longo prazo é pertinente. O tratamento se torna uma medida paliativa para, talvez, controlar a bacteremia e os sintomas agudos, mas sem perspectiva de erradicação da infecção.

2.2.2 Cuidados Paliativos e Limitação de Suporte na UTI

Este caso exemplifica a importância da integração dos cuidados paliativos na UTI, especialmente em pacientes idosos e frágeis.

- **Definição de Teto Terapêutico:** Estabelecer um limite para o uso de DVA (ex: noradrenalina 0.5 mcg/kg/min) é uma estratégia prática para alinhar o tratamento intensivo com os objetivos de cuidado do paciente, evitando a chamada **distanasia** (prolongamento artificial do processo de morte com sofrimento).
- **Controle de Sintomas:** O uso de **morfina em BIC** para controle da dispneia e da dor é uma medida padrão-ouro em cuidados paliativos. A dispneia, neste contexto, é tratada como “dor torácica”, e os opioides são a terapia mais eficaz.

Ponto de Atenção: A comunicação com a família é essencial. É crucial que eles compreendam que a limitação de suporte não significa “não fazer mais nada”, mas sim uma mudança no foco do cuidado: da tentativa de cura a qualquer custo para a promoção de conforto, dignidade e qualidade de vida (e de morte).

Tópico 3: Abordagem da Hipervolemia e Lesão Hepática em Paciente Transplantado

3.1 Apresentação do Caso Clínico: Sra. Maria de Assis, 57 anos

- **Histórico:** Paciente de 57 anos, pós-transplante (Tx) hepático.
- **Admissão na UTI:** Quadro de **hipervolemia severa (anasarca)**, lesão renal aguda e alteração de função hepática.
- **Tratamento e Evolução:**
 - Realizou hemodiálise por dois dias consecutivos, com foco em ultrafiltração, apresentando melhora expressiva do edema.
 - Exames laboratoriais mostram **ascensão de enzimas hepáticas (TGO 78 → 97) e bilirrubinas (5.55 → 5.77)**, levantando a suspeita de **rejeição do enxerto hepático**.
 - Mantém-se hemodinamicamente estável, sem necessidade de DVA.
 - Balanço hídrico ficou negativo em 765 mL nas últimas 24h, com boa resposta à diálise.

3.2 Aprofundamento e Insights Clínicos

3.2.1 Diagnóstico Diferencial da Disfunção do Enxerto Hepático

A alteração das provas de função hepática em um paciente transplantado é uma emergência médica e requer uma investigação sistemática. Os principais diagnósticos diferenciais incluem:

1. **Rejeição Aguda:** É uma das causas mais comuns, especialmente nos primeiros meses pós-Tx. Geralmente é mediada por células T. O diagnóstico definitivo é feito por **biópsia hepática**.
2. **Complicações Vasculares:** Trombose da artéria hepática, trombose da veia porta ou estenose da anastomose biliar podem levar à isquemia e disfunção do enxerto. A investigação é feita com **Ultrassom Doppler** das estruturas vasculares hepáticas.
3. **Complicações Biliares:** Fístulas ou estenoses na via biliar são comuns e podem levar à colestase e infecção (colangite).
4. **Infecções:** Infecções virais, como Citomegalovírus (CMV) ou vírus Epstein-Barr (EBV), ou a recorrência da doença de base (ex: Hepatite C), podem causar inflamação e disfunção.
5. **Toxicidade por Drogas:** Os próprios imunossupressores (ex: Tacrolimus, Ciclosporina) podem ser nefrotóxicos e hepatotóxicos.

Ponto-Chave: No contexto de elevação de transaminases e bilirrubinas, a **rejeição aguda** é a principal hipótese a ser descartada. A conduta imediata, enquanto se aguarda a investigação, é otimizar os níveis dos imunossupressores e proceder com os exames de imagem (Doppler) e, se necessário, a biópsia hepática, que ainda é o padrão-ouro.

3.2.2 Manejo da Hipervolemia e Síndrome Hepatorrenal

A anasarca e a lesão renal aguda (creatinina em queda de 1.63 para 1.25 após diálise) sugerem uma descompensação que pode envolver a **Síndrome Hepatorrenal (SHR)**.

- **Diretrizes (EASL Clinical Practice Guidelines on kidney failure in patients with advanced liver disease, 2022):**
 - A SHR-IRA (Lesão Renal Aguda) é uma complicação grave, caracterizada por uma vasoconstrição renal intensa em resposta à vasodilatação esplâncnica da hipertensão portal.
 - O tratamento se baseia em **vasoconstritores (Terlipressina é a droga de escolha) associados à albumina**.
 - No caso da Sra. Maria, a **terapia renal substitutiva (TRS)** foi indicada primariamente pela **hipervolemia refratária**, o que é uma indicação clássica. A TRS ajuda a controlar o volume e o meio interno, servindo como ponte enquanto se investiga e se trata a causa base da disfunção hepática.

Resumo Objetivo e Diretrizes

- **Caso 1 (Sr. Ronaldo - DAC):**

- **Ponto-chave:** A decisão entre ICP e RM em DAC multiarterial é do **Heart Team**. O alto risco de AVC por doença carotídea justificou a ICP, apesar da anatomia complexa.
- **Diretriz:** *2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization.*
- **Bradicardia:** Investigar causas farmacológicas, isquêmicas e reflexas. Holter é indicado para avaliar a necessidade de marcapasso definitivo se a bradicardia persistir após a suspensão de drogas bradicardizantes.
- **Referência:** *Knuuti J, et al. Eur Heart J. 2020.*

- **Caso 2 (Sra. Maria de Lourdes - Sepses/Palição):**

- **Ponto-chave:** Em endocardite de dispositivo com bacteremia persistente, a extração do sistema é **Classe I**. Na impossibilidade (decisão de limitação), o objetivo do tratamento muda de curativo para **paliativo**.
- **Diretriz:** *2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis.*
- **Limitação de Suporte:** A definição de um teto para DVA e o uso de opioides para dispneia são práticas essenciais de cuidados paliativos na UTI, evitando a distansia.
- **Referência:** *Delgado-Guay M, et al. Intensive Care Med. 2017. (Sobre cuidados paliativos na UTI).*

- **Caso 3 (Sra. Maria de Assis - Tx Hepático):**

- **Ponto-chave:** Disfunção aguda do enxerto hepático exige investigação para **rejeição, causas vasculares e biliares**. A **biópsia hepática** é o padrão-ouro para o diagnóstico de rejeição.
- **Diretriz:** *EASL Clinical Practice Guidelines on liver transplantation. J Hepatol. 2016.*
- **Hipervolemia e Lesão Renal:** A TRS é indicada para controle volêmico refratário. O quadro pode ser uma manifestação da Síndrome Hepatorrenal (SHR-IRA), cujo tratamento de escolha é **Terlipressina e albumina**.
- **Referência:** *Angeli P, et al. J Hepatol. 2022. (Diretriz de falência renal na doença hepática avançada).*

